EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 68274
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-07-29 10:23:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA BERNARDITA MORALES ARIAS			RUN	: 10.937.159-9
F.Nac	: 22-07-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-25	Fecha Egreso	: 2023-07-29 10:23:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G61.0-SINDROME DE GUILLAIN-BARRE

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Diagnosticos de Egreso

Guillain Barre variante sensitiva ataxica, o A-CIDP variante CANOMAD
HTA
DM2
Hipotiroidismo
Insuficiencia Venosa Cronica EEII
Glaucoma Angulo Estrecho.

Farmacos habituales
- Aspirina 100 mg, 1 comp al día, VO
- Atorvastatina 20 mg, 1 comp al día, VO
- Glibenclamida 5 mg, 1 comp al día, VO
- Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, VO
- Levotiroxina 50 ug, 1 comp al día, VO
- Losartan 50 mg, 1 comp al día, VO
- Metformina 850 mg, 1 comp cada 12 horas, VO
- Omeprazol 20 mg, 1 comp al día, VO
- Cilostazol 100 mg cada 12 horas

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G61.0-SINDROME DE GUILLAIN-BARRE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Inició el jueves 20/07/23 cuadro rapidamente progresivo consistente en sensación vertiginosa asociado a debilidad en 4 extreimdades, diplopia e hipoestesia distal de 4 extremidades.
Con profundización de diplopia y alteración de la marcha por lo que decide consultar en SU de HSC.
Al ingreso se registra en DAU Fc 109 mg/dL, PA 140/88 mmHg, T° 37°C, Sat 98% y HGT 144 mg/dL. Es evaluada en SU y se complementó estudio con laboratorio sin alteraciones de relevancia. Al examen de ingreso destaca ataxia e hiperrreflexia por lo que se realizó estudio de LCR con aumento muy escaso en proteinorraquia.

Ingresa a UPC con sospecha de SGB variante MF para tratamiento y seguimiento.

ECN+EMG sin hallazgos significativos (radiculopatia cervical y lumbar, crónica e inactiva en segmentos C6 y L5 bilateral).

Se realiza estudio inicial y EMG , se procede a iniciar tratamiento con inmunoglobulina EV 30g diarios por 5 dosis con excelente evolucion clinica.

Evaluada por neurologia y ante buena evolucion se decide manejo en hodom y control en policlinico de especialidad en 1 a 2 semanas

Importante señalar que durante toda la hospitalizacion no fue necesario hipoglicemiantes orales ni insulina por consiguiente su diabetes podria manejarse con dieta en domicilio.

Examen neuolorigo Al alta.
-Mental: vigil, OTE, atención N, lenguaje N, gnosias N
-PC: CV N, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, paresia mirada conjugada horizontal (RM y RL) bilateral mayor a derecha y para
la supraversión de la mirada, motilidad y sensibilidad faciales N, muy leve rinolalia, nistagmo(-), úvula central, elevación palatina
simétrica, fuerza ECM y trapecios N, motilidad lingual N
-Motor: M4+ abducción hombro derecho, flexión rodilla izquierda y extensión hallux izquierdo; resto fuerza M5 en todos los segmentos;
hipotonia generalizada leve, hiporreflexia severa braquirradial bilateral, resto ROT ausentes, RCP flexor bilateral, leve temblor de acción EESS,
RCP flexor bilateral, TEPE(-)
-Sensitivo: hipoestesia multimodal largo dependiente de las 4 EE, de predominio en EEII, leve a moderado en modalidad termo-algesica y muy severa
de modalidad palestésica (esta última ausente en pies y ortejos), dudoso nivel sensitivo segmentario a nivel de T6 y L3
-Cerebelo: conservado
-Signos meningeos(-)

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones
2. - Regimen Liviano Diabetico
3. - Reposo Relativo.
4. - Kinesioterapia Respiratoria y Motora
5. - Seguimiento por Fono y TO.
6. - Aspirina suspender, sin indicacion de profilaxis primaria.
7. - Atorvastatina 20 mg, 1 comp al día, VO
8. - Glibenclamida suspender
9. - Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, VO
10. - Levotiroxina 50 ug, 1 comp al día, VO
11. - Losartan 50 mg, 1 comp al día, VO
12. - Metformina 850 mg, 1 comp cada 12 horas, VO
13. - Linagliptina 5mg al dia vo.
14. - Omeprazol 20 mg, 1 comp al día, VO
15. - Cilostazol 100 mg cada 12 horas VO
16.
17. -Control en policlinico neurologia en 1 a 2 semanas
18. -Control en urgencias SOS.
19. -Control en su cesfam para ajuste farmacologico de diabetes en 1 mes.

Control en: 7 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE

JEFE SERVICIO

16178692-N